

ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES O ARTERITIS DE LA TEMPORAL O ARTERITIS DE HORTON

J. Montánchez Mateo, S. Calleja Antolín, A. Martínez González.

INTRODUCCIÓN

La Arteritis de células gigantes (ACG) es la vasculitis más común después de los 50 años, aunque la mayor prevalencia se da entre los 75 y 85 años. Se estima que 2/3 son mujeres. La incidencia oscila entre 7 y 10/100.000 individuos mayores de 50 años en nuestro medio. Suele comprometer a vasos de mediano y gran calibre, y manifiesta tropismo por la aorta torácica, arterias oftálmica, vertebral, subclavia distal, axilar y ramas de la carótida externa (como son las arterias temporal y occipital).

Presenta asociación con el HLA-DR4.

Etiología y fisiopatogenia inmunológica

Aún no está clara la etiología. Se postula una reacción cruzada a diversos antígenos, como virus (parvovirus B19, citomegalovirus, influenza y varicela), bacterias (*Chlamydia pneumoniae*), toxinas exógenas, autoantígenos, y fármacos.

Las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, de la adventicia arterial viajan a los nódulos linfáticos e inician una cascada de secreción, vía TLR, de quimioquinas (CCL18, CCL19 y CCL21) y citoquinas proinflamatorias, IL-6, IL-18, IL-12, IL-23, IL-6 y IL-1β para reclutar y activar a los linfocitos TCD4 y macrófagos. Los linfocitos T CD4 activados ingresan a través de la vasa vasorum de la adventicia.

Se han encontrado evidencias de que existen dos subtipos de linfocitos T involucrados, TH1 y TH17 y secretan interferón γ e IL-17 respectivamente. El interferón media la formación del infiltrado celular y los macrófagos secretan IL-6 y IL-1β en la adventicia. El infiltrado en la pared arterial está organizado en granulomas (complejos formados por linfocitos T activados y macrófagos) y células gigantes multinucleadas (macrófagos activados fusionados).

La consecuencia de la inflamación transmural por los granulomas, es la hiperplasia de la capa íntima ocasionando estenosis y oclusión concéntrica en el lumen arterial.

Manifestaciones clínicas

La oclusión arterial produce isquemia, que puede ser brusca o insidiosa, según la arteria afectada.

El paciente suele presentar cefalea refractaria a analgésicos, más frecuente en región temporal, con hipersensibilidad de la arteria temporal a la palpación, hiperestesia en cuero cabelludo y claudicación mandibular (dolor o incomodidad desencadenado con la masticación y se alivia con el reposo, es el síntoma clásico de la ACG), habiéndose descrito ageusia y glosalgia. Si afecta otros territorios pueden manifestarse como accidente cerebrovascular, sordera, neuropatía periférica, vasculitis coronaria con disección y rotura aórtica.

La oclusión luminal de la arteria ciliar posterior, rama de la oftálmica, puede resultar en Neuritis óptica isquémica anterior (NOIA) tipo arterítica, lesión relativamente rara (15% de pacientes con ACG) pero temible, ya que puede abocar a la amaurosis irreversible, sobre todo si no se instaura un tratamiento precoz ante la sospecha inicial. Es la complicación grave más frecuente de la ACG. Con menos frecuencia se da la oclusión de la arteria central de la retina (10%). Amaurosis fugax, o diplopía pueden preceder a la ceguera parcial o total, unilateral o bilateral y se desarrollan en el

30-35% de los pacientes con ACG no tratados en la semana siguiente al inicio del cuadro. Para evitar la pérdida de visión, se debe iniciar precozmente, infusión de altas dosis de glucocorticoides.

La ACG se asocia a polimialgia reumática (PR) hasta en un 30-40% de los casos. La PR se define por dolor y rigidez, normalmente con debilidad proximal en grupos de músculos del cuello, hombros, cintura escapular y pelviana de forma inversa, un 10% de pacientes con PR desarrollarán en algún momento ACG.

En cuanto a la afectación sistémica se pueden detectar: fiebre (en el 50%), malestar general, anorexia, pérdida de peso (en más del 50%), sudoración nocturna y depresión. Supone un importante diagnóstico diferencial dentro de la Fiebre de Origen desconocido en el anciano.

DIAGNÓSTICO

Criterios de clasificación del American College of Rheumatology para arteritis de células gigantes (ACG) (1990)

- Edad $\geq$ de 50 años al momento de inicio de la enfermedad.
- Cefalea de nueva aparición o distinta a la existente.
- Anomalías arteria temporal con Hipersensibilidad a la palpación en el recorrido de la arteria temporal o disminución de pulso
- VSG elevada, VSG > 50 mm/h según método Westergren.
- Biopsia arterial temporal con Vasculitis con mononucleares o granulomas de células gigantes multinucleadas.

Si están presentes 3 criterios de los 5 se diagnostica la ACG con S=93,5% y E=91,2%.

Síntomas más frecuentes

Cefalea (80%), fiebre (50%), pérdida de peso (55%), alteraciones oculares globalmente (25%), PMR (50%), Claudicación mandibular (60%), neuralgia facial o de cuello cabelludo (40%)

Pruebas iniciales

En todos los pacientes en que sospechamos ACG:

- Hemograma.
- Bioquímica glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, GOT, GPT, GGT, amilasa, proteínas, VSG y PCR (alta S y baja E).
- Cuagulación básica.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral.
- Electrocardiograma.

Suelen hallarse anemia normocrómica o hipocrómica, de trastornos crónicos y trombocitosis como parámetro de fase aguda.

Exploración neuro-oftalmológica

Siempre que exista sintomatología neurológica u ocular.

Pruebas de imagen programadas

- Ecografía color Doppler: se observa el edema de la inflamación transmural como una señal hipoecoica, conocida como signo del Halo. Tiene sensibilidad del 75% y Especificidad de 83%. Papel no establecido claramente (gran dependencia del explorador).

- RMN angio de grandes vasos o Tomografía por Emisión de Positrones: solo en casos seleccionados de difícil diagnóstico.
- RMN cerebral: elección si hay focalidad neurológica de cualquier tipo.

Anatomía Patológica

El diagnóstico definitivo es la Biopsia de 1.5 a 2 cm de longitud de la arteria temporal. Identifica el 85-95% de los casos. Las lesiones suelen ser parcheadas y si la biopsia es normal, no descarta la enfermedad. En casos seleccionados, tras un resultado negativo puede ser positiva la biopsia de la arteria contralateral.

Diagnóstico diferencial y pruebas a realizar en su caso:

- Otras vasculitis (PAN, ANCA+, vasculitis del SNC primaria): Solicitar además de lo anterior: ANCA, ANA, ENAS, FR, COMPLEMENTO, CRIOGLOBULINAS, SEROLOGÍA VIH, VHC Y VHB. Proteínas en orina y sedimento.
- Patología de la articulación temporomandibular
- Enfermedad cerebrovascular no vasculítica o patología retiniana-nervio óptico de otro origen como NOIA no arterítica.
- Artropatía de otra etiología
- Enfermedades autoinmunes miscelánea (Lupus eritematoso sistémico, Dermatopolimiositis, Sinovitis), patología tumoral o paraneoplásica
- Otras causas de Fiebre de origen desconocido.

TRATAMIENTO

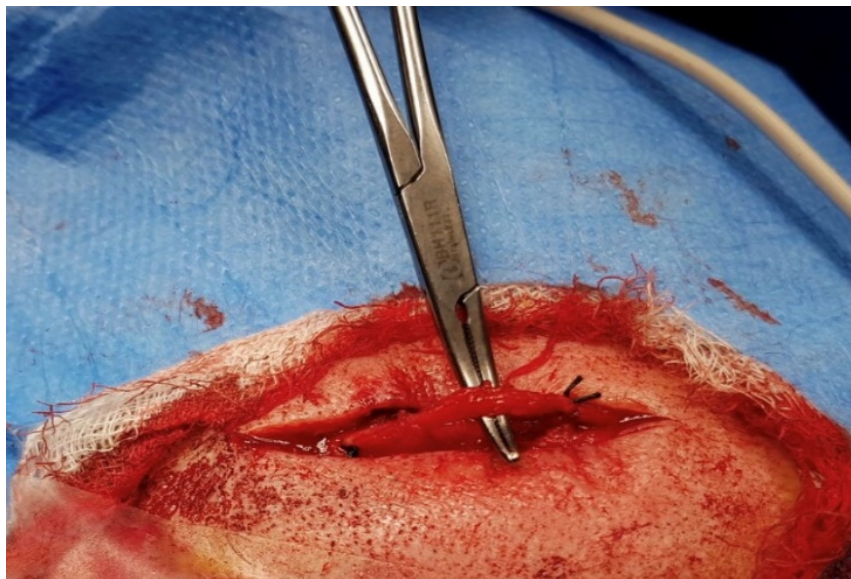
Tratamiento en urgencias

Los corticoides son el pilar del tratamiento, reducen rápidamente los síntomas y previenen en la mayoría de los pacientes la pérdida de visión.

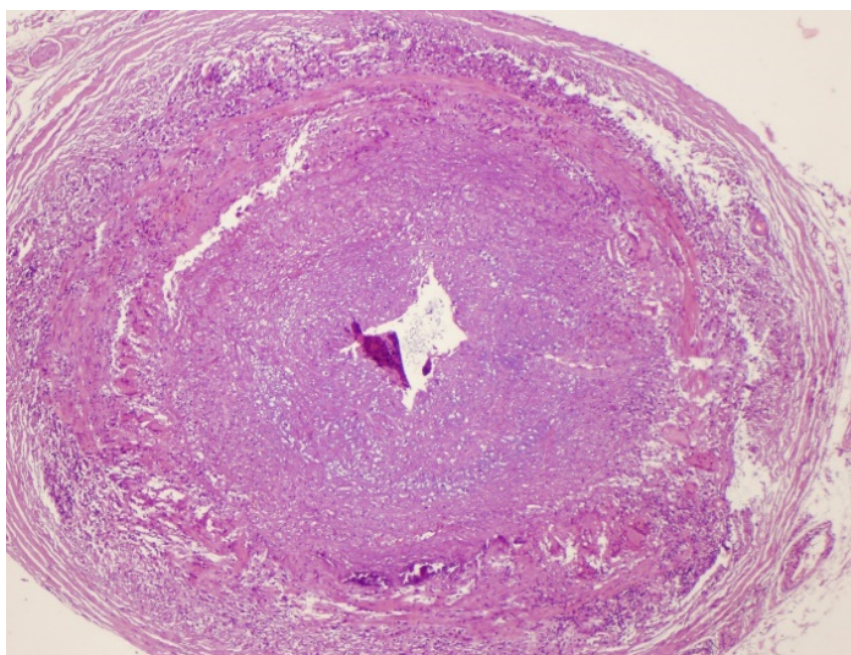
- **Manejo Inicial:** Terapia de Inducción
 - Prednisona 1mg/Kg/día (entre 40 a 60mg/24h) durante 2 a 4 semanas y posterior reducción gradual si los síntomas mejoran. Si presenta alteraciones visuales iniciar con metilprednisolona 500 a 1000 mg IV cada 24h durante 3-5 días, con la finalidad de prevenir la pérdida de visión del otro ojo.
 - Aspirina 100 mg/día (si factores riesgo CV o cualquier fenómeno isquémico)
 - Omeprazol solo si riesgo de hemorragia digestiva
 - Calcio-vitamina D para prevención de osteoporosis en todos los pacientes
 - Si afectación neurooftalmológica: Bolus de Metilprednisolona (entre 500 mg y 1g/ día durante 3-5 días) y realizar interconsulta a oftalmología / neurología.
- **Terapia de Mantenimiento** (duración media de 2 a 3 años)
 - Disminuir la prednisona en 10-20% la dosis inicial, por mes. Cuando la dosis sea 10 mg/día, reducir a 1 mg/mes.
 - Considerar profilaxis frente a Neumonía por Pneumocystis, cuando la dosis sea de 20 mg o más diario de prednisona.
- **Manejo de brotes:**
 - **Brote severo:** Repetir la terapia de inducción con Prednisona 1mg/Kg/día
 - **Brote leve:** Incrementar un 10 a 20% de la dosis actual de Prednisona.

Los corticoides suprimen las citoquinas IL-6, IL-1, IL-23, e IL-17, sin embargo, no controlan la producción de la IL-12 e IFN- γ , las cuales promueven la cronicidad de la vasculitis. Actualmente

se investiga la eficacia de abatacept y Tocilizumab.

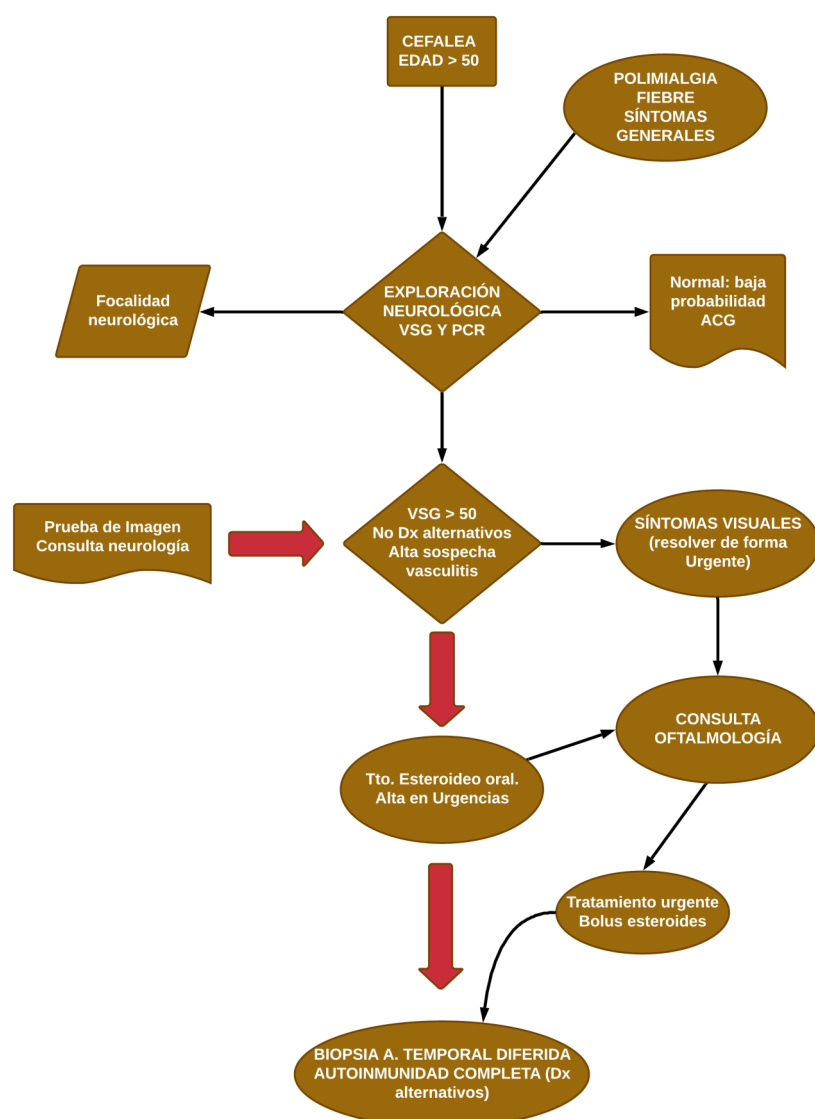


Procedimiento de Biopsia de arteria temporal intraoperatoria.



Biopsia de Arteria Temporal, Hiperplasia de capa íntima y oclusión concéntrica luminal

Algoritmo de manejo de Urgencias



BIBLIOGRAFÍA

- Weyand CM, Goronzy JJ. Giant-Cell Arteritis and Polymyalgia Rheumatica. N Engl J Med 2014; 371; 1 50-57.
- Guevara M, Kollipara CS. Recent Advances in Giant Cell Arteritis. Current Rheumatology Reports 2018; 20:25
- Weyand CM, Goronzy JJ. Medium- and Large-Vessel Vasculitis. N Engl J Med 2003; 349; 2 160-169.
- Weyand CM, Liao YJ, Goronzy JJ. The Immunopathology of Giant Cell Arteritis: Diagnostic and Therapeutic Implications. J Neuroophthalmol. 2012 September; 32(3): 259–265*.*
- Chapel, Helen. 2014. Essentials of clinical immunology. 6TH EDITION. UK. John Wiley & Sons
- R.Cervera.G.Espinoza.M.Ramos-Casals.J.Hernández-Rodríguez.M.C.Cid. 2015. Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Diagnóstico y tratamiento. 5º Edición. España. Editorial Médica Panamericana.
- Acosta-Mérida A, Francisco Hernández, F. Diagnóstico y tratamiento de una arteritis temporal en urgencias. Semin Fund Esp Reumatol. 2012;13(4):134–141